

1018336-37.2019.8.26.0562

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Tratamento Médico-Hospitalar

Magistrado: Sheyla Romano Dos Santos Moura

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... permanecendo escondida em meio ao tráfico (?) em franco uso e abuso... perda completa da noção de crítica a inviabilizá-la pragmática e socialmente. Indicado internação involuntária e compulsória”.

Posteriormente, a correquerida foi submetida a internação compulsória no PAI (Polo de Atenção Intensiva em Saúde Mental Santos), cuja equipe técnica elaborou relatório médico, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara da Fazenda Pública

Praça José Bonifácio, s/nº, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1018336-37.2019.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1018336-37.2019.8.26.0562

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Tratamento Médico-Hospitalar

Requerente:

Maria Fernanda Mota

Requerido:

Prefeitura Municipal de Santos e outros

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sheyla Romano Dos Santos Moura

Vistos.

MARIA FERNANDA MOTA ajuizou MEDIDA PROTETIVA PARA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de MUNICÍPIO DE SANTOS, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e IAKINI APARECIDA MOTA (inclusão em decisão de fls. 31), visando à internação compulsória de sua filha Iakini Aparecida Mota para tratamento de saúde, haja vista ser usuária e dependente de substâncias químicas entorpecentes. Sustenta a requerente que sua filha se encontra em estado grave de saúde física e mental, uma vez que, em decorrência de sua dependência química, tem se comportado de forma descontrolada, atentando contra sua própria vida. Narra que a correquerida Iakini mora com a requerente, sua avó e sua tia e que, em consequência de seu consumo de drogas, furta objetos da casa para adquirir tóxicos e foge frequentemente para locais de risco, conhecidos pelo consumo desenfreado de entorpecentes, lá permanecendo por longos períodos. Aduz que tal situação atinge toda a família, que sofre por dias sem notícias de Iakini e procura incessantemente

encontrá-la nas ruas. Esclarece que a maior dificuldade enfrentada é o fato de Iakini não aceitar qualquer proposta de auxílio clínico, tratamentos ou internações, o que a tem colocado em permanente estado de risco, pois sai de casa fora de controle e já foi molestada. Expõe que já houve tentativa de levar Iakini a locais de auxílio, UPAs, Hospitais Municipais e CAPS que atendem doentes mentais pelo SUS, porém ela terminou por receber alta sem encontrar-se apta para o convívio social e familiar, haja vista que tais locais só oferecem tratamentos de urgência. Afirma que incumbe aos entes públicos requeridos prestar o atendimento necessário à recuperação da saúde de Iakini, que se recusa a se submeter voluntariamente a qualquer tratamento efetivo, cabendo à família solicitar sua internação involuntária em clínica especializada para tratamento de seu transtorno. Indicou, por fim, a autora que a correquerida encontrava-se internada no PAI - polo de Atenção Intensiva em Saúde Mental Santos, contudo, estava na iminência de receber alta. Pede, portanto, concessão de liminar para que se oficie ao PAI-Polo de Atenção Intensiva em Saúde Mental Santos para a permanência de Iakini no local e posterior transferência para clínica especializada para dependentes químicos através de internação involuntária, ou, subsidiariamente, na hipótese de Iakini não estar internada no PAI, sua condução coercitiva para avaliação médica e constatação da necessidade de internação involuntária como medida adequada de tratamento com posterior internação compulsória, se necessária. Por fim, requer a procedência da ação para internação compulsória de Iakini a fim de se submeter a tratamento médico necessário para sua reabilitação pelo tempo necessário e, oportunamente, tratamento ambulatorial e intervenções sociais pertinentes. Juntou documentos (fls. 13/30).

Deferida a gratuidade de justiça às fls. 31 e a liminar às fls. 35.

A Fazenda Estadual foi citada e apresentou contestação às fls. 49/65. No mérito, defende que a política nacional de saúde mental recomenda o atendimento aos portadores de transtornos mentais através de tratamentos extra-hospitalares, sendo a internação medida subsidiária aos demais recursos terapêuticos, consoante o Art. 4º da lei nº 10.216/2001. Alega, por fim, a impossibilidade de atendimento de um indivíduo com comprometimento do atendimento coletivo, diante da escassez de recursos públicos. Pede a improcedência da ação.

O Município de Santos foi citado e apresentou contestação às fls. 89/94. Preliminarmente arguiu a falta de interesse processual. No mérito, defende a ausência de prova da imprescindibilidade da internação compulsória e de obrigação legal do município em fornecê-la. Alega que não se mostra admissível atribuir ao Município a responsabilidade que supera sua capacidade financeira, comprometendo o atendimento de outras prioridades, também fixadas constitucionalmente. Enfatiza que a execução da medida pretendida pela autora viola o princípio da separação dos poderes e invade a seara de discricionariedade conferida ao Poder Público. Por fim, pede a extinção da ação ou, subsidiariamente, a improcedência do pedido.

O Ministério Público, no parecer de fls. 97/103, manifestou-se pelo deferimento dos pedidos com a determinação de internação compulsória da correquerida em clínica de reabilitação para dependentes químicos, sob a coordenação do Estado e Município ou, subsidiariamente, em estabelecimento particular com as despesas custeadas pelos entes públicos de forma solidária.

Foi proferida decisão às fls. 147/148 determinando que os entes públicos correqueridos providenciassem a internação compulsória perseguida em estabelecimento público ou privado adequado ao tratamento necessário, sob pena de apreensão de seus ativos financeiros.

Sobrevieram decisões de apreensão de ativos financeiros no valor de R\$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) às fls. 191 e 197.

A parte autora apresentou as notas fiscais de fls. 259/260, emitidas por RB Centro

de Reabilitação Ltda, comprovando a internação de Iakini Aparecida Mota em clínica particular.

A correquerida Iakini foi citada às fls. e apresentou contestação por negativa geral através de curador especial às fls. 385/387.

Decisão saneadora às fls. 419/420, determinando a produção de prova pericial a fim de verificar a necessidade contemporânea da internação involuntária, que restou inviabilizada pela informação de fls. 457/458, que noticiou que a correquerida Iakini desligou-se voluntariamente da clínica particular de recuperação e encontra-se atualmente nas ruas do município de São Vicente, em local incerto.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A matéria debatida nos autos dispensa a produção de outras provas e possibilita o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mais, as partes são legítimas e estão bem representadas.

Não há nulidades ou irregularidades a sanar.

Prefacialmente, afasto a preliminar de falta de interesse processual arguida pelo Município de Santos.

Reputo presente o interesse processual uma vez que a ação ajuizada se mostra necessária, adequada e útil à tutela do interesse primário contido na pretensão.

Trata-se de pedido de internação compulsória de Iakini Aparecida Mota para tratamento de dependência química em razão de omissão do Poder Público.

É certo que tal demanda encontra-se amparada pela garantia constitucional do direito à saúde, consoante art. 196 da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Porém, é evidente que a possibilidade de obtenção da internação compulsória junto à Administração Pública não assegura sua concreta e real disponibilidade nos postos de atendimento do Estado e do Município, de forma que o interesse processual se mantém íntegro diante dessa circunstância em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que está previsto no Art. 5º da Constituição Federal:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Passo ao mérito.

À luz dos elementos de convicção existentes nos autos, a ação é procedente. Explico.

O Direito à Saúde e ao tratamento adequado está garantido constitucionalmente ao cidadão, principalmente, com o fim de preservar sua integridade e dignidade humana, consoante já mencionado no Art. 196 da Constituição Federal.

Tal obrigação é pertinente ao Estado na concepção mais ampla.

Esta orientação foi pacificada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo com a aprovação, pelo C. Órgão Especial, da Súmula nº 37, segundo a qual “a ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno”.

A Lei nº 10.216/11 dispõe que:

Art. 4º - A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

...

Art. 6º - A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

No caso em tela, levando-se em consideração a documentação apresentada nos autos, restou devidamente comprovado que Iakini Aparecida Mota necessita efetivamente de internação, a qual foi atestada por médica psiquiátrica do Município às fls. 19/20, manifestando expressamente que: “frequentes são os retornos à compulsão e obsessão pelas substâncias psicoativas... sai... foge... desaparece... e se (ilegível) por dias... sem dar notícias... permanecendo escondida em meio ao tráfico (?) em franco uso e abuso... perda completa da noção de crítica a inviabilizá-la pragmática e socialmente. Indicado internação involuntária e compulsória”.

Posteriormente, a correquerida foi submetida a internação compulsória no PAI (Polo de Atenção Intensiva em Saúde Mental Santos), cuja equipe técnica elaborou relatório médico, psicológico e social de fls. 132/137, que sugere alta médica à paciente desde 26/08/2019 e indicação de continuidade do tratamento em ambiente extra-hospitalar (fls. 133).

Entretanto, observo que o relatório de fls. 138/139 elaborado em 31/10/2019 e apresentado pelo Município de Santos através do Centro de Atenção Psicossocial Orquidário, indica expressamente que Iakini: “Ficou acolhida conosco de 28/05/2019 a 08/08/2019, entre evasões e retornos. Pediu-se a vaga no PAI, onde ela deu entrada no dia 08/08/2019. Diante do histórico da usuária, e a pedido dos familiares a equipe achou válida uma internação mais longa. A família por iniciativa própria, entraram com o pedido no Ministério Público, solicitando uma internação em clínica especializada. O trâmite deste processo é a justificativa para que ela permaneça no PAI até o momento apesar da sua alta... Enquanto equipe, acreditamos que o tempo que a usuária de manteve internada, apesar de não ter sido realizada em um equipamento apropriado, cumpriu um papel de afastamento do uso abusivo de substâncias... Em visita à usuária no PAI no dia 24/10/2019 a mesma nos recebe com hostilidade, pouco contato e na única fala que dirige a nós, refere o que estão fazendo aqui, não quero me tratar, não vou voltar pro CAPS, assim que tiver alta tudo vai ser como antes, já sei o que tenho que fazer vou sumir no mundo e ninguém mais vai me achar (sic)” (fls. 138/139).

Portanto, resta evidente que, embora houvesse a sugestão de alta pela equipe do PAI, o relatório elaborado pelo CAPS pouco tempo depois demonstra que não houve qualquer evolução no quadro de Iakini, o que leva à conclusão de que deveria haver a continuidade de sua internação.

Tanto é que o novo relatório médico de fls. 224 elaborado em 24/04/2020 pela psiquiatra da clínica de reabilitação particular em que Iakini permaneceu internada a partir de 30/10/2019 indica expressamente que: “Não se encontra apta a receber alta e retornar ao convívio em sociedade, pois apresenta alto risco de recaída.”

Igualmente, o documento fornecido pelo psicólogo Anderson Lopes Cardoso às fls. 258, em 14/07/2020, indica que Iakini : “não está preparada para receber alta

clínica e retornar para a sociedade”.

Após, a partir de 09/01/2022, Iakini iniciou tratamento em nova clínica, conforme declaração de fls. 412, cujo método adotado é a internação voluntária (fls. 412). Porém, foi noticiado às fls. 457/458, que a paciente se desligou desta última instituição em 08/08/2022, de forma voluntária, e encontra-se atualmente em situação de rua (fls. 457).

Em suma, houve três tentativas de internação da paciente, em três locais diferentes, de 2019 a 2022, sem sucesso, à vista da informação da requerente de que Iakini regressou às ruas.

Reforço que os dois últimos locais em que a correquerida esteve internada não foram obtidos por força da tutela concedida e sim por iniciativa de sua família, sendo presumível, dessa forma, a dificuldade de continuidade de um tratamento adequado e a longo prazo para pessoas carentes, acabando por inviabilizá-lo.

Saliente-se que, em se tratando de saúde pública, o cidadão não pode ser penalizado pela burocracia do Estado.

Nesse sentido:

“A singularidade do caso (menor impúbere portador de doença rara denominada Distrofia Muscular de Duchene), a imprescindibilidade da medida cautelar concedida pelo poder Judiciário do Estado de Santa Catarina (necessidade de transplante das células mioblásticas, que constitui o único meio capaz de salvar a vida do paciente) e a impostergabilidade do cumprimento do dever político-constitucional que se impõe ao Poder Público, em todas as dimensões da organização federativa, de assegurar a todos a proteção à saúde (CF, art. 196) e de dispensar especial tutela à criança e ao adolescente (CF, art. 6º, c/c art. 227, § 1º) constituem fatores, que, associados a um imperativo de solidariedade humana, desautorizam o deferimento do pedido ora formulado pelo Estado de Santa Catarina (fls.2/30).O acolhimento da postulação cautelar deduzida pelo Estado de Santa Catarina certamente conduziria a um desfecho trágico, pois impediria, ante a irreversibilidade da situação, que o ora requerido merecesse o tratamento inadiável a que tem direito e que se revela essencial à preservação de sua própria vida. Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da Republica (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida.Por tal motivo, indefiro o pedido formulado pelo Estado de Santa Catarina, pois a decisão proferida pela Magistratura catarinense- longe de caracterizar ameaça à ordem pública e administrativa local,como pretende o Governo estadual (fls. 29) - traduz, no caso em análise, um gesto digno de reverente e solidário apreço à vida de um menor, que, pertencente a família pobre, não dispõe de condições para custear as despesas do único tratamento médico-hospitalar capaz de salvá-lo de morte inevitável (fls. 76).Publique-se.Brasília, 31 de janeiro de 1997. Ministro CELSO DE MELLO Vice-Presidente, no exercício da Presidência (RISTF, art. 37, I)” (STF - Pet: 1246 SC, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 31/01/1997, Data de Publicação: DJ 13/02/1997 PP-*****)

Destarte, a internação compulsória torna-se necessária tanto pela falta de adesão ao tratamento ambulatorial, quanto porque a dependência química retira do paciente a capacidade de autodeterminação, não sendo possível a Iakini, enquanto permanece sob domínio do vício, discernir acerca do prejuízo que seu comportamento gera a sua saúde, inclusive com risco de morte por eventual overdose.

Ademais, é indiscutível pelos relatos carreados aos autos, notadamente o documento

de fls. 24/30 que a situação da paciente coloca em risco também sua família e a própria sociedade.

Ressalto, ainda, que o objeto da ação, qual seja a internação compulsória do dependente químico, não se exauriu em razão das várias tentativas de internação noticiadas nos autos, tanto nas dependências do PAI quanto nas duas clínicas particulares pelas quais Iakini passou em tratamento, tendo em vista que, a despeito da saída da correquerida de forma voluntária (fls. 458) o objetivo desta medida é a superação de sua dependência química, embora extremamente difícil e sujeita a recaídas.

Portanto, embora noticiado às fls. 457 que atualmente a correquerida esteja nas ruas, em local incerto, flagrante a necessidade de avaliação médica atual da dependente química, em caráter compulsório, para efeito de renovação da medida de internação compulsória, se for indicada a sua necessidade.

A vida e a saúde da correquerida Iakini não podem ser colocadas em perigo pela falta de condição econômica para custear o tratamento necessário, cabendo ao Poder Público a responsabilidade de supri-lo.

A requerente demonstrou sua hipossuficiência, sendo assistida, inclusive, por profissional indicado através do Convênio com a Defensoria Pública Estadual.

Dessa forma, cabe ao Município e ao Estado fornecer à paciente o tratamento necessário que excede sua capacidade econômica e de sua família, em estabelecimento adequado, restando afastadas quaisquer justificativas quanto às dificuldades orçamentárias ou seu elevado custo.

Outrossim, se os profissionais que atenderam e acompanharam Iakini prescreveram a internação solicitada, conforme acima relatado, esta forma de tratamento é a adequada para o seu caso.

O próprio relato de retorno de Iakini às ruas em função de sua dependência química já denota que ela permanece em grave situação de risco, adotando comportamentos prejudiciais a si e à sociedade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. Medida protetiva para internação compulsória c/c pedido de tutela antecipada. Internação involuntária de pessoa que padece de vício em drogas e álcool. Obrigação do Estado em fornecer tratamento médico para pessoas que não podem arcar com os custos. 1. Internação compulsória. Conjunto probatório que demonstra exaustivamente que o internando sofre de vício em drogas e álcool, e apresenta comportamento desregrado, colocando em risco a própria segurança e a de terceiros. Prova dos autos contundente quanto à necessidade de internação para tratamento do requerido. 2. Obrigação do ente apelante decorrente do artigo 3º da Lei nº 10.216/2.001, que expressamente prevê ser responsabilidade do Estado, além do desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais. Manutenção da r. sentença nesse aspecto que se impõe. 3. Nego provimento aos recursos voluntários.” (TJ-SP - AC: 10012268420198260607 SP 1001226-84.2019.8.26.0607, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 23/03/2021, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/03/2021)

“REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - DEPENDENTE QUÍMICO - Pretensão inicial voltada à internação compulsória de dependente químico, para tratamento de sua condição de saúde, a ser custeada pela Administração Pública Municipal e Estadual - possibilidade - demonstração da

necessidade do tratamento, por meio de laudo médico circunstanciado e fundamentado, em que a internação compulsória é prescrita, de forma urgente, sob pena de comprometimento da saúde do requerido e risco de morte - direito constitucional à saúde - Dever do Poder Público de custear o tratamento de saúde àqueles que dele necessitam - inteligência do art. 196, da CF/88, e legislação atinente ao SUS - necessidade e eficácia da internação não infirmadas pelos réus - sentença integralmente mantida. Reexame necessário desprovido, com observação." (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10024651920218260619 SP 1002465-19.2021.8.26.0619, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 13/05/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2022)

Por fim, tratando-se de responsabilidade solidária, caberá, se for o caso, ação de regresso por parte do ente que despendeu os gastos com o tratamento em face do outro, nos termos do Art. 283 do Código Civil.

Mais não é necessário.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar os réus Município de Santos e Fazenda do Estado de São Paulo a providenciar a devida internação compulsória em hospital ou clínica adequada para o caso específico, público, conveniado ou que custeiem todas as despesas necessárias em clínica particular pelo tempo que for necessário ao tratamento de Iakini Aparecida Mota, sob pena de multa diária de R\$ 500,00 até o limite de R\$ 20.000,00, devendo receber alta somente após avaliação por equipe médica competente, comunicando o juízo.

Em razão da paciente encontrar-se atualmente em situação de rua, oficie-se à CROSS (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde), ao CAPS e à PAI Baixada Santista, conforme indicado às fls. 79, para que os entes públicos demandados forneçam, no prazo de 10 dias, vaga em estabelecimento psiquiátrico adequado ao tratamento da paciente.

Obtida a vaga, expeça-se mandado de busca e apreensão em face de Iakini Aparecida Mota e comunique-se novamente à CROSS (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde), ao CAPS e à PAI Baixada Santista para que acompanhem o cumprimento da ordem e coordenem a transferência da paciente ao estabelecimento psiquiátrico em que ela receberá tratamento de modo definitivo.

Pela sucumbência, arcarão os correqueridos com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro nos termos do artigo 85, §8º do CPC, por equidade em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Sentença sujeita à remessa necessária.

Arbitro os honorários da advogada nomeada à parte autora em 100% do valor constante da tabela do Convênio de Assistência Judiciária. Expeça-se a certidão oportunamente.

Arbitro os honorários advocatícios do curador especial, na forma da tabela do convênio OAB-SP/DPE-SP, consoante as especificações constantes do ANEXO IX, em vista do quanto disposto no art. 1º, §6º, desse ato. Expeça-se a respectiva certidão oportunamente.

Ciência ao Ministério Público.

P.I.C.

Santos, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA